

Zdrowy *narcyzm*

Cel terapii NPD nie jest eliminacja narcyzmu, tylko jego **transformacja**. Stabilna samoocena, ambicje, duma z osiągnięć i empatia mogą iść w parze.

CZAS: 10 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Kohut (1971, 1977); Pincus & Lukowitsky (2010)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz różnicę między zdrowym a patologicznym narcyzmem (sekcja 01) — sześć wymiarów. **2** · Zrozumiesz *kontinuum* narcyzmu — nie kategorię (sekcja 02). **3** · Wykonasz autorefleksję na czterech wymiarach swojego narcyzmu (sekcja 03). **4** · Zobaczysz, dlaczego *walidacja potrzeb narcystycznych* jest warunkiem ich dojrzewania (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zdrowy narcyzm to **fundament** psychicznego dobrostanu — stabilna samoocena, zdrowe ambicje, zdolność do dumy z osiągnięć i przyjmowania uznania, połączone z empatią i wzajemnością. Kohut (1971, 1977) jako pierwszy zauważył, że celem terapii *nie* jest eliminacja narcyzmu, tylko jego **transformacja** w dojrzałe formy: humor, twórczość, mądrość. Wprowadził koncepcję *rozwojowej linii narcyzmu* — od archaicznych form (grandiozyny self) do dojrzałych. Pincus & Lukowitsky (2010) w psychometrycznym ujęciu wykazali, że narcyzm jest *wymiarowy* (kontinuum), **nie kategoriyczny** — każdy człowiek ma jakiś poziom narcyzmu, pytanie tylko, czy jest on adaptacyjny czy nieadaptacyjny. Adaptacyjny narcyzm: stabilna samoocena, ambicja z empatią, zdolność do przyjmowania krytyki, radość z sukcesów *innych*. Nieadaptacyjny narcyzm (NPD): niestabilna samoocena, eksploatacja, brak empatii, oscylacja grandiozja ↔ wstyd. **Cel terapii NPD:** przejście z patologicznego na zdrowy — *nie* eliminacja, *nie* deflacja, tylko transformacja. „Mogę być dumny/-a z siebie *i jednocześnie* doceniać innych.” Bez tej ramy pacjent rozumie terapię jako wymóg „bycia pokornym” — co aktywuje schemat defektywności, pogłębia wstyd i prowadzi do *depresji narcystycznej*. Po roku takiej terapii pacjent cierpi bardziej, ale strukturalnie się nie zmienia.

01

Sześć wymiarów — zdrowy vs patologiczny narcyzm

1 · SAMOOCENA

Zdrowy: stabilna, wewnętrzna.

Patologiczny: wahliwa, zależna od potwierdzenia z zewnątrz.

2 · AMBICJE

Zdrowy: dążenia z empatią — mogę chcieć więcej i jednocześnie doceniać innych.

Patologiczny: dążenia z eksploatacją.

3 · REAKCJA NA KRYTYKĘ

Zdrowy: tolerancja, refleksja, ewentualna zmiana zachowania.

Patologiczny: furia lub wycofanie, dewaluacja krytyki.

4 · EMPATIA

Zdrowy: obecna, afektywna i poznawcza.

Patologiczny: ograniczona albo nieobecna, instrumentalna.

5 · SUKCES INNYCH

Zdrowy: radość, inspiracja, możliwość uczenia się.

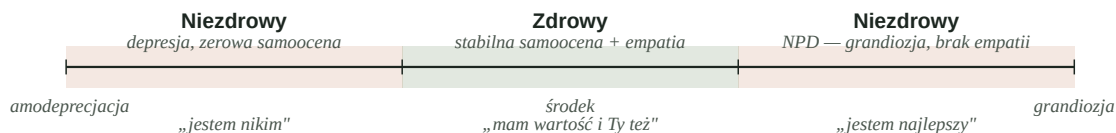
Patologiczny: zazdrość, dewaluacja, narcisstic injury.

6 · BLISKOŚĆ

Zdrowy: autentyczna, z zachowaną autonomią.

Patologiczny: idealizacja-dewaluacja, fuzja albo dystans.

02 Narcyzm jako kontinuum — nie kategoria



Cel terapii to **środek**, nie przeciwna strona. Pacjent z NPD często myśli, że alternatywą dla grandiozji jest poniżanie się — i broni grandiozji jak życia. Trzeba pokazać **trzecią drogę: realistyczna duma + empatia**. Pincus & Lukowitsky (2010): narcyzm jest wymiarem, nie zerojedynkową kategorią.

03 Autorefleksja — na czterech wymiarach

Odpowiedz uczciwie. Wynik to *orientacja*, w jakim miejscu spektrum jesteś — nie diagnoza.

MOJA SAMOOCENA

— stabilna czy wahliwa? Co ją łatwo „obraża”?

MÓJ SPOSÓB RADZENIA Z KRYTYKĄ

— refleksja, furia, wycofanie, dewaluacja?

SUKCES INNYCH

— jak reaguję, gdy ktoś bliski mi osiąga coś, co ja chciałem/-am?

MOJA EMPATIA

— czy potrafię rzeczywiście wejść w czyjąś sytuację?

04 Walidacja potrzeb — warunek transformacji

FAŁSZYWY CEL TERAPII

„Być bardziej pokornym/-ą, mniej myśleć o sobie, ustępować innym.” To wzmacnia schemat defektywności i prowadzi do *depresji narcystycznej*. Po roku takiej terapii — bardziej cierpienia, brak zmiany strukturalnej.

PRAWDZIWY CEL TERAPII

„Twoja ambicja, kreatywność i pragnienie uznania są **wartościowe**. Pracujemy nad ich **zdrowymi formami**.” Walidacja potrzeb narcystycznych jako *uniwersalnych ludzkich potrzeb*, nie jako moralnego defektu.

Klucz: każdy człowiek potrzebuje *zdrowego narcyzmu* — uznania, znaczenia, podziwu, dumy z osiągnięć. W NPD te potrzeby są realizowane *destrukcyjnie*. Terapia zmienia **metody**, nie **potrzeby** (Kohut 1971). Mechanizm transformacji: w bezpiecznej relacji terapeutycznej pacjent traci wstyd → przestaje potrzebować obronnej grandiozji → dojrzewa do realnej dumy. Warunek: *walidacja potrzeb narcystycznych* jako uniwersalnych — bez tego pacjent broni się jeszcze mocniej. Z walidacją — może zacząć eksperymentować z dojrzałszymi formami: humorem, twórczością, mądrością (Kohut). To długi proces (2–5 lat), ale dający *strukturalną* zmianę.